

Mở Niệu Đạo Ra Tầng Sinh Môn

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Lỗ mở vĩnh viễn để thoát nước tiểu ở tầng sinh môn

Phẫu thuật mở niệu đạo ra tầng sinh môn tạo ra một lỗ mở vĩnh viễn để thoát nước tiểu ở tầng sinh môn — vùng giữa bìu và hậu môn. Phẫu thuật này được thực hiện khi niệu đạo bị hẹp, có sẹo hoặc tổn thương quá nặng không thể phục hồi. Sau phẫu thuật, bạn sẽ ngồi để đi tiểu qua lỗ mở này thay vì qua đầu dương vật. Tờ thông tin này giải thích cách phẫu thuật hoạt động, cách chuẩn bị và những gì sẽ xảy ra.

Về ca phẫu thuật này

Hẹp niệu đạo là đoạn niệu đạo bị sẹo, thu hẹp, cản trở dòng nước tiểu. Khi chỗ hẹp dài, tái phát sau phẫu thuật, hoặc niệu đạo bị tổn thương quá nặng, bác sĩ phẫu thuật sẽ đưa **phần niệu đạo lành** (phía sau chỗ hẹp) ra da tầng sinh môn và khâu mở ra để tạo lỗ mở mới lâu dài. Nước tiểu sau đó thoát ra ngoài qua lỗ mở này.

Đây là giải pháp **đáng tin cậy, bền vững**, tránh phẫu thuật phức tạp hoặc phải mổ lại nhiều lần — phù hợp với hẹp niệu đạo phức tạp hoặc khi bạn muốn tránh nhiều ca mổ.

Điều cần biết

Thay đổi chính là bạn sẽ **ngồi để đi tiểu** qua lỗ mở mới; nước tiểu không còn ra từ đầu dương vật. Hầu hết nam giới thích nghi tốt và hài lòng. **Dương vật vẫn giữ nguyên vị trí** — cảm giác và cực khoái thường không thay đổi, hầu hết nam giới vẫn có thể cương dương (một số có thể nhận thấy sự thay đổi). Theo thời gian, lỗ mở có thể **bị hẹp lại**; nếu vậy, một thủ thuật nhỏ thường có thể mở rộng lại được.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.

Hẹp niệu đạo

Đoạn niệu đạo bị sẹo, thu hẹp, cản trở dòng nước tiểu.

Tầng sinh môn

Vùng giữa bìu và hậu môn, nơi tạo lỗ mở mới.

Mở niệu đạo ra tầng sinh môn

Phẫu thuật đưa niệu đạo ra lỗ mở vĩnh viễn ở tầng sinh môn.

Lỗ mở (stoma)

Lỗ mở mới để nước tiểu thoát ra ngoài.

Hẹp lỗ mở

Lỗ mở bị thu hẹp theo thời gian — thường có thể xử lý bằng thủ thuật nhỏ.

Ống thông

Ống mềm được đặt trong một đến hai tuần trong khi lỗ mở lành lại.

Gây mê toàn thân

Thuốc giúp bạn ngủ và không đau trong suốt ca mổ.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, vùng tầng sinh môn có thể bị sưng, bầm và đau trong 1–2 tuần — ngâm nước ấm (sitz bath), chườm đá và thuốc giảm đau sẽ giúp ích. Một ống thông được đặt trong khi mổ. Nhiều người về nhà trong ngày hoặc sau một đêm.

Cách chuẩn bị (Trước phẫu thuật)

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống** — tuân thủ mọi hướng dẫn trước mổ (nhịn ăn, ngừng thuốc theo chỉ dẫn kể cả thuốc chống đông máu).
- **Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng (sẽ điều trị trước); bạn sẽ được dùng kháng sinh. **Không hút thuốc** — làm chậm lành thương.
- Chân bạn sẽ được đỡ trên giá đỡ trong khi mổ. Lên kế hoạch cho **ống thông khoảng 1–2 tuần** và nhờ người đưa về nhà.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đã được **xạ trị vùng chậu** — lỗ mổ dễ bị hẹp lại hơn
- Đang dùng thuốc chống đông máu hoặc đang bị nhiễm trùng

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được gây mê hoặc gây tê, chân được đỡ trên giá; kháng sinh được dùng.
- 2 Qua vết rạch ở tầng sinh môn, bác sĩ tìm đến phần niệu đạo lành phía sau chỗ hẹp và cắt bỏ hoặc vượt qua phần bị sẹo.
- 3 Phần niệu đạo lành được đưa ra da và khâu mở tạo lỗ mổ rộng mới; ống thông được đặt vào và vết thương được khâu lại.

Sau phẫu thuật

- Vùng tầng sinh môn có thể **sưng, bầm và đau** trong 1–2 tuần. Ngâm nước ấm, chườm đá và thuốc giảm đau giúp ích; giữ vùng này sạch sẽ.
- **Ống thông ở lại khoảng 1–2 tuần**, sau đó nhóm chăm sóc sẽ rút ra. Sau đó bạn đi tiểu **ngồi** qua lỗ mổ mới.
- **Tránh nâng vật nặng, rặn, đạp xe và quan hệ tình dục** trong vài tuần; tránh ngồi trực tiếp lên vùng này theo hướng dẫn.
- Nếu **dòng tiểu yếu dần theo thời gian**, lỗ mổ có thể đang hẹp lại — hãy báo cho nhóm chăm sóc, một thủ thuật nhỏ có thể mở lại được.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Ống thông bị tuột ra hoặc ngừng dẫn lưu, hoặc bạn **không thể đi tiểu** sau khi rút ống
- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc vết thương ngày càng đỏ, đau, sưng hay có dịch chảy ra
- Chảy máu nhiều

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Mở niệu đạo ra tầng sinh môn tạo lỗ mổ vĩnh viễn để thoát nước tiểu — dùng khi niệu đạo bị hẹp hoặc tổn thương quá nặng không thể sửa chữa. Sau đó bạn **ngồi để đi tiểu**.
2. Đây là giải pháp bền vững, đáng tin cậy, tránh phẫu thuật kéo dài hoặc mổ lại. **Dương vật vẫn giữ nguyên**; cảm giác và khả năng cương dương thường không đổi.
3. Dự kiến ống thông khoảng 1–2 tuần. Lỗ mổ có thể hẹp lại theo thời gian — hãy báo cho nhóm chăm sóc nếu dòng tiểu yếu đi.